

УДК: 616.51-006.6-076

Б.Т.Кусаинова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

## Возможности морфоцитологической верификации опухолей почек

**Аннотация.** В статье рассматриваются возможности цитологического метода в диагностике опухолей почки. Использование вышеуказанного метода исследования позволяет верифицировать доброкачественные и злокачественные опухоли почек с определением гистологических вариантов.

**Ключевые слова:** доброкачественные и злокачественные опухоли почек, цитологическая верификация, диагностика.

В структуре всех злокачественных новообразований опухоли почек (ОП) составляют 2-3%. Рак почки (РП) - наиболее часто (85-90%) встречающаяся злокачественная опухоль [1,8]. Доброкачественные новообразования почки составляют 6-8% и представлены, в основном, ангиолипомой, аденомой и онкоцитомой [2,3,4,6].

РП у мужчин встречается в 2 раза чаще, чем у женщин. Заболевают обычно люди в возрасте 35-60 лет [7,10].

По Республике Казахстан (РК) в среднем заболеваемость раком почки составляет от 5,2 о/оооо до 6,0 о/оооо, а смертность 2,6-2,7 о/оооо на 100 тыс. населения. Наибольшее количество заболевших РП это больные из - Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областей (9,6-11,8 о/оооо). Наименьшее количество в - Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях (1,6-3,2 о/оооо) [5].

Нами изучен материал, касающийся цитологической диагностики опухолевых заболеваний почек у 49 больных находившихся на лечении в КазНИИОиР. Анализ свидетельствует, что мужчин было 21 (42,8%), женщин - 28 (57,2%) больных. Возраст больных варьировал от 5 месяцев до 79 лет. Количество пациентов до 10 лет составило - 14 (30%) и 50-59 лет - 11 (22,4%) больных.

### Цель исследования

Изучение возможности цитологического метода в диагностике опухолей почек.

### Материал и методы

Цитологический материал получен во время операции у больных с клиническим диагнозом рак почки, которые находились на лечении в отделении онкоурологии. Мазки окрашивались методом Романовского. Во всех случаях имели место опухоли не леченные до операции. Цитологические варианты почечноклеточного рака (ПКР) основывались на международной гистологической классификации ВОЗ [9].

Все больные поступили в КазНИИОиР с клиническим диагнозом «опухоль почки». При верификации цитологически выявлено следующее (таблица №1).

Как видно из таблицы у 5 пациентов (10,2%) цитологически был выставлен диагноз «реактивно-пролиферативный процесс», на основании выявления клеток почечного эпителия с признаками пролиферации и незначительной атипии, на фоне воспалительной инфильтрации. У 5 пациентов (10,2%) был установлен диагноз аденома. Цитологическая картина при аденоме была представлена опухолевыми клетками округлой, кубической формы, небольшого размера с округлыми четкими ядрами и границами. Эпителиальные клетки располагались в виде мономорфной тубулярной, железистоподобной структуры, в них отмечались признаки пролиферации.

У 18 (36,8%) больных был выявлен гипернефроидный рак, на основании следующей цитологической картины: обилие полиморфных клеток опухоли располагающихся обширными полями на фоне межклеточного вещества и обрывков капилляров. Ядра гиперхромные, эксцентричные, с компактным неравномерным хроматином и, единичными крупными, округлыми ядрышками. Цитоплазма пенная, обильно вакуолизированная.

У 15 (30,6%) больных детского возраста (от 5 мес. до 10 лет) (у 8 мальчиков и 7 девочек) цитологически диагностирована нефробластома (НБ), (опухоль Вильмса). Клетки опухоли располагались на фоне оксифильной субстанции и бесструктурной массы, в виде плотных полей и многослойных структур, а также округлых скоплений наподобие клубочков, железистых и тубулярных образований, встречались единичные стромальные элементы опухолевых бластем.

У 6 (12,2%) больных было диагностировано «злокачественное новообразование без гистологического варианта» ввиду отсутствия различных компонентов характерных для опухолевых клеток и смешанной цитологической картины, который в дальнейшем подтвержден морфологически (таблица № 2).

В последующем нами были сопоставлены данные цитологического и гистологического за-

Таблица 1 – Цитологически установленный диагноз

| Цитологический<br>диагноз \<br>Клинический<br>диагноз | Реактивно-<br>пролифе-<br>ративный<br>процесс |      | Аденома       |      | Гипернефро-<br>идный рак |      | Нефробла-<br>стома |      | Злокачест-<br>венное<br>образование<br>(без<br>верифи-<br>кации<br>варианта) |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------|------|--------------------------|------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                       | Абс.<br>число                                 | %    | Абс.<br>число | %    | Абс.<br>число            | %    | Абс.<br>число      | %    | Абс.<br>чис                                                                  | %    |
| Опухоль почки<br>Всего - 49<br>больных                | 5                                             | 10,2 | 5             | 10,2 | 18                       | 36,8 | 15                 | 30,6 | 6                                                                            | 12,2 |

Таблица 2. Морфология наблюдений

| Морфологический<br>диагноз / Клинический<br>диагноз | Число<br>случаев | Варианты цитологического<br>диагноза рака почки                      | Варианты<br>гистологического<br>диагноза |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Злокачественное –<br>почки                          | 1                | злокачественное<br>новообразование без<br>варианта                   | светлоклеточный вариант<br>рака почки    |
| Злокачественное новообразо-<br>вание почки          | 1                | С-г почки, предположительно<br>гранулярноклеточный и<br>вариант рака | гранулярноклеточный<br>вариант рака      |
| Злокачественное новообразование<br>почки            | 2                | злокачественное но-<br>вообразование без варианта                    | веретенноклеточный вари-<br>ант рака     |
| Злокачественное новообразо-<br>вание почки          | 2                | злокачественное но-<br>вообразование без варианта                    | папиллярный вариант<br>рака.             |

ключений. При этом было установлено, что у 1(16,6%) больного с гистологическим диагнозом «светлоклеточный вариант рака почки» - цитологическая картина была представлена обилием опухолевых клеток располагающихся разрозненно, тяжами, пластами. Клеточные элементы, скапливались вокруг межклеточного вещества и капилляров в виде «пера». Полиморфные клетки крупных размеров, с обильной пенистой цитоплазмой, с четкими контурами, с гиперхромными ядрами округлой или овальной формы, имеющими неровные контуры, грубый рисунок хроматина и наличием интенсивно окрашенных ядрышек. Данный вариант рака был выставлен позже, после сопоставления с гистологическим заключением. У 1 (16,6%) больного гистологически установлен диагноз гранулярноклеточный вариант - который имел признаки светлоклеточного рака, но с базофильной зернистостью цитоплазмы, от мелко-точечной и необильной до крупной, густо заполняющей всю цитоплазму.

У 2 (33,3%) больных был гистологически выставлен диагноз веретенноклеточный вариант — цитологически же клетки опухоли имели вытянутую, причудливую веретенообразную форму, располагались изолированно друг от друга. Был выражен клеточный и ядерный полиморфизм.

У 2(33,3%) больных гистологически выставлен диагноз папиллярный вариант. При пересмотре цитологического материала и сопоставлении с гистологическим заключением клетки опухоли имели вид папиллярных структур, с четкими границами, отмечался умеренный клеточный и ядерный полиморфизм.

Таким образом, анализ нашего материала свидетельствует, что с помощью цитологического метода можно верифицировать доброкачественные и злокачественные опухоли почек с определением основных гистологических вариантов. Как указывают –Relley Carolyn, Cohen Michael (1996), Харченко В.П., Каприн А.Д.(2000), В.И. Новик, Л.А. Красильникова (2008), при имеющихся трудностях в верификации гистотипов опухолей и опухолеподобных заболеваний почек достоверность цитологического исследования колеблется от 70 до 97 %. Следовательно, цитологический метод необходимо использовать для правильного дальнейшего лечения больных.

## Список литературы

1. Цитологическая диагностика опухолей и предопухолевых процессов /под ред. А.С. Петровой.- М.: Медицина, 1985.
2. Красильникова Д.А., Новик В.И. Возможности цитологической

диагностики опухолей Вильмса у детей / Цитологическая лаборатория НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова МЗ РФ.- СПб, 2008.

3. Фигурин М., Подрезульский К.Э. Рак почки // Русский медицинский журнал.- 1998.- Т. 6.-С. 10.

4. Мельникова В.Ю. Цитологическая диагностика опухолей почек.- М., 2009.

5. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2010 год (статистические материалы).- Алматы, 2011.- 108 с.

6. Клиническая онкоурология / под ред. Е.Б. Марибаха.- М, 1975.- С.5.

7. Клиническая онкоурология / под ред. Б.П. Матвеева.- М., 2000.- С. 5-39.

8. М.Ф. Трапезникова. Опухоли почек.- М., 1978.

9. Н.А. Лопаткин, А.Г. Пугачев. Детская урология.- М., 1986.

10. Международная Гистологическая Классификация ВОЗ. 1998.

11. Клиническая нефрология /под ред. ЕМ. Тареева.- М, 1983.- Т.

12. Relley Carolyn, Cohen Michael. Diagnosis and panagement of renal cell carcinoma.- 1996.- Vol. 48.- С. 1165-77.

13. Харченко В.П., Каприн А.Д. Методы диагностики опухолей почек.- М., 2000.

Тұжырым

Б.Т.Кусаинова

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Бүйрек қатерлі ісігінің морфоцитологиялық анықталу мүмкіндігі.

Бұл мақалада бүйрек қатерлі ісігінің цитологиялық анықтау диагностикасы қарастырылған. Жоғарыда көрсетілген зерттеу әдістерінен бүйректің қатерсіз және қатерлі ісігінің гистологиялық түрлерін анықтауға болады.

Түйінді сөздер: бүйректің қатерлі және қатерсіз ісігі, цитологиялық әдісі, диагностика.

Summary

Kusainova B.T.

Kazakh Scientific Institute Oncology and Radiology

Opportunities morphocytologically verification of renal tumors

The article discusses the possibilities of cytological methods in the diagnosis of kidney tumors. Using the method described above allows the study to verify the benign and malignant renal tumors with defined histologic variants.

Key words: benign and malignant tumors of the kidneys, the cytological diagnosis.